

Rasgos vs Trastorno

1. Introducción y relevancia clínica

El ser humano tiene una **personalidad única**, compuesta por patrones estables de **pensamiento, emoción y conducta** que definen su modo de relacionarse con el entorno.

Estos **rasgos de personalidad** son **adaptativos y flexibles** dentro de un rango normal.

Sin embargo, cuando dichos rasgos se vuelven **extremos, rígidos e inflexibles**, generando **malestar subjetivo o deterioro funcional**, se convierten en un **trastorno de personalidad (TP)**.

La distinción entre rasgo y trastorno es esencial porque:

- Evita el **sobrediagnóstico** (no toda conducta difícil o excéntrica es patológica).
- Permite **identificar pacientes que realmente requieren intervención psiquiátrica**.
- Orienta el **manejo terapéutico**, ya que los TP necesitan estrategias psicoterapéuticas de largo plazo.

□ En el **EUNACOM**, este tema se aborda mediante casos de pacientes con características de personalidad acentuadas pero funcionales, y se pregunta si corresponde o no a un TP.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Definición operativa

- **Rasgo de personalidad:** tendencia estable a pensar, sentir o actuar de cierta manera, dentro del espectro de la normalidad.
- **Trastorno de personalidad:** patrón inflexible, desadaptativo y persistente que interfiere en el funcionamiento social, laboral o emocional.

Ejemplo:

□ Un individuo perfeccionista que logra altos estándares laborales → **rasgo anancástico** (normal).

□ El mismo perfeccionismo, pero que impide completar tareas o genera conflicto interpersonal → **trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad (anancástico)**.

2.2. Modelo dimensional vs categorial

Modelo	Descripción	Ejemplo
Categorial (DSM-5 clásico)	Divide la personalidad en tipos o categorías (paranoide, límite, etc.).	“El paciente cumple criterios de TP límite”.
Dimensional (CIE-11, DSM-5 Sección III)	Evalúa los rasgos según su intensidad y disfunción , en un continuo.	“El paciente presenta rasgos evitativos moderados con disfunción leve”.

□ Actualmente, el modelo **dimensional** es más aceptado científicamente porque refleja mejor la variabilidad de la personalidad humana.

2.3. Factores determinantes

- **Genéticos:** herencia de rasgos temperamentales (impulsividad, ansiedad).
- **Neurobiológicos:** desequilibrio serotoninérgico, disfunción prefrontal-límbica.
- **Psicosociales:** apego inseguro, abuso infantil, ambientes caóticos.
- **Culturales:** normas sociales que modulan qué comportamientos se consideran patológicos.

En conjunto, determinan un **continuo entre normalidad y patología** más que una frontera absoluta.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Rasgos de personalidad (normalidad funcional)

- Persistentes en el tiempo, pero **flexibles** y **adaptativos**.
- No interfieren con la vida laboral, social o familiar.
- No generan sufrimiento personal significativo.
- Pueden ser extremos pero funcionales (p. ej., un cirujano perfeccionista).

3.2. Trastorno de personalidad (anormalidad disfuncional)

- Rasgos rígidos e inflexibles.
- Deterioro funcional evidente.
- Dificultad para adaptarse a las normas sociales o laborales.
- Problemas crónicos en relaciones interpersonales.
- Resistencia a reconocer el problema (“el mundo tiene la culpa”).

3.3. Diagnóstico diferencial

Situación	Características diferenciales
Rasgo acentuado	No hay sufrimiento ni disfunción; el paciente se adapta.
Trastorno de personalidad	Inflexibilidad persistente, deterioro funcional, inicio precoz.
Trastorno del ánimo	Síntomas episódicos (no estables), reversibles con tratamiento.
Trastorno psicótico	Pérdida del juicio de realidad.

Trastorno de ansiedad o adaptativo

Reacción a un evento identificable; curso autolimitado.

- Clave diagnóstica: el TP es **egosintónico** (el paciente no percibe su conducta como problema), mientras que los trastornos del ánimo o ansiedad son **egodistónicos** (causan malestar al paciente).
-

3.4. Ejemplos clínicos comparativos

Caso clínico	Diagnóstico probable
Hombre exigente, puntual, pero funcional y eficaz →	Rasgos anancásticos (no TP).
Mujer impulsiva, con relaciones intensas y autolesiones recurrentes →	TP límite.
Joven introvertido que disfruta trabajar solo pero sin deterioro →	Rasgo esquizoide (no TP).
Hombre conflictivo, sin empatía ni remordimiento, con delitos repetidos →	TP antisocial.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Diagnóstico clínico

El diagnóstico sigue los **criterios DSM-5** generales para TP:

1. Patrón persistente e inflexible en ≥ 2 de las siguientes áreas:
 - Cognición.
 - Afectividad.

- Funcionamiento interpersonal.
 - Control de impulsos.
2. Inicio en adolescencia o adultez temprana.
 3. Estabilidad a lo largo del tiempo.
 4. Deterioro funcional o malestar clínicamente significativo.
 5. No atribuible a otra enfermedad mental o sustancia.

4.2. Herramientas de apoyo

- Entrevista clínica estructurada (SCID-II, MINI Plus).
- Inventario de personalidad de Millon (MCMI-III).
- Cuestionario de los cinco grandes (Big Five).
- **Historial evolutivo detallado:** relaciones, trabajo, eventos vitales.

En APS, no se requieren test formales: basta con **detectar rigidez conductual y deterioro funcional**.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1. Manejo general

El enfoque terapéutico depende del grado de disfunción:

Situación	Enfoque
Rasgos acentuados	Psicoeducación, refuerzo de estrategias adaptativas, seguimiento.
Trastorno leve-moderado	Derivación a psicoterapia (TCC o psicodinámica).

Trastorno grave (TLP, antisocial)

Intervención multidisciplinaria (COSAM, Hospital de Día).

5.2. Psicoterapia

- **Terapia cognitivo-conductual (TCC):** modificar esquemas disfuncionales.
- **Terapia dialéctico-conductual (TDC):** manejo emocional y prevención de autolesiones (TLP).
- **Terapia de esquemas (Young):** trabajo con creencias nucleares tempranas.
- **Terapia interpersonal:** mejora de relaciones sociales.

□ En el sistema público chileno (MINSAL/COSAM), la **TCC y TDC** son las más utilizadas.

5.3. Farmacoterapia (solo como coadyuvante)

- **ISRS (sertralina, escitalopram):** síntomas depresivos o ansiosos.
- **Estabilizadores del ánimo (lamotrigina, valproato):** impulsividad.
- **Antipsicóticos atípicos (quetiapina, risperidona):** descontrol conductual o distorsión cognitiva.
- **Ansiolíticos:** evitar uso prolongado.

La farmacoterapia **no modifica la estructura de la personalidad**, solo controla síntomas asociados.

5.4. Rol de atención primaria

- Detectar **rasgos disfuncionales persistentes**.
- Ofrecer **psicoeducación y contención emocional**.
- Evitar confrontaciones o juicios morales.

- Promover **adhesión y derivar a salud mental** cuando exista disfunción significativa.
 - Coordinar con **COSAM** y **red SENDA** si existe consumo asociado.
-

6. Complicaciones y pronóstico

6.1. Complicaciones

- **Riesgo de comorbilidad psiquiátrica:** depresión, ansiedad, abuso de sustancias.
- **Dificultad de adherencia terapéutica.**
- **Riesgo suicida (TLP).**
- **Conflictos laborales y familiares crónicos.**

6.2. Pronóstico

- **Rasgos acentuados:** buen pronóstico, alta adaptabilidad.
 - **TP leves:** mejora con psicoterapia y soporte social.
 - **TP graves:** curso crónico, con recaídas y periodos de mejoría parcial.
 - Factores positivos: apoyo familiar, motivación, adherencia terapéutica.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. Los **rasgos de personalidad** son variantes normales; los **trastornos** implican deterioro.
2. El **inicio temprano y estabilidad en el tiempo** son claves diagnósticas.
3. Los TP son **egosintónicos**, los trastornos afectivos no.

4. La **psicoterapia** es el tratamiento principal; los fármacos son coadyuvantes.
 5. En APS, la prioridad es **contención y derivación**, no etiquetado diagnóstico.
 6. **No toda persona conflictiva tiene un TP.**
 7. El **modelo dimensional (CIE-11)** enfatiza la gravedad y los rasgos predominantes, más que la categoría.
-



Errores comunes

- Diagnosticar TP en una crisis reactiva o en un episodio depresivo.
 - Interpretar rasgos de carácter como enfermedad.
 - Usar psicofármacos en exceso para tratar personalidad.
 - No evaluar el impacto funcional antes de etiquetar el diagnóstico.
 - Estigmatizar al paciente (“manipulador”, “difícil”).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **diferencia entre rasgo y trastorno** radica en la **flexibilidad y el impacto funcional**.
2. Un **rasgo de personalidad** puede ser acentuado pero adaptativo.
3. Un **trastorno de personalidad** implica rigidez, inflexibilidad y deterioro social o laboral.
4. El diagnóstico es **clínico y evolutivo**, basado en persistencia desde la adolescencia.
5. El tratamiento es **psicoterapéutico**, con enfoque en regulación emocional y cambio de esquemas.
6. En APS, el objetivo es **contener, educar y derivar adecuadamente**.

7. El **modelo dimensional (CIE-11)** reemplaza las categorías fijas por niveles de gravedad y rasgos dominantes.